

腹壁硬纤维瘤 病因、诊断、治疗、论著摘要.

腹壁硬纤维瘤 28 例报告

高维生 李小毅 桑新亭 刘子文 唐伟松

腹壁硬纤维瘤虽然是一种较少见的良性肿瘤,但其临床特点及其治疗对策均有其特殊性,我们总结了 1978 至 1998 年间 28 例腹壁硬纤维瘤病例的诊治经验,现报告如下

一、资料与方法

1. 一般资料:本组 28 例患者中男性 1 例,45 岁,女性 27 例,年龄在 23~42 岁之间,平均 29 岁;病史为 45 d 至 52 个月不等;女性病例均为已婚,其中 23 例有生育史;3 例有下腹部手术史,1 例伴有结肠多发腺瘤样息肉者,1 例伴结肠多发腺瘤样息肉且同时有会阴部皮样囊肿者;1 例有腹壁硬纤维瘤家族史。28 例中 23 例是首诊患者,5 例为复发病例,其中 1 例女性 32 岁,为第 5 次复发。

2. 临床特点:腹壁硬纤维瘤一般无症状,临床上主要表现为腹壁上的实性、质硬、边界不太清楚、但表面光滑的卵圆形或圆形包块。本组中 24 例是在无意中发现肿瘤,4 例自觉患处有胀感或微痛后发现肿瘤。肿瘤位于右下腹近腹股沟韧带处有 13 例,左下腹近腹股沟韧带处有 6 例,左上腹直肌 4 例,脐旁右侧 2 例,脐旁左侧 1 例,另 2 例为多发,其中 1 例下腹壁硬纤维瘤多达 8 个。最大肿瘤为 14 cm × 10 cm × 8 cm,最小肿瘤直径为 1.5 cm;23 例首诊患者中肿瘤长径 ≤ 5 cm 的 16 例,肿瘤长径在 5~10 cm 之间的 5 例,肿瘤长径 ≥ 10 cm 的 2 例;5 例复发患者首次来我院就诊时肿瘤大小分别为:长径 ≤ 5 cm 的 2 例,长径在 5~10 cm 之间的 2 例,长径 ≥ 10 cm 的 1 例。经 B 超检查的病例均表现为腹壁层边界不清的低回声实性肿块。切除标本的病理特点为:肉眼见肿块无包膜,局限肌肉内或与筋膜相连,切面灰白,交织的纤维小梁伸入周围肌肉组织内;镜下见肿瘤由高分化的成纤维细胞和纤维间质构成,成纤维细胞核深染,但核分裂极少,肿瘤边缘可见纤维组织侵入周围肌肉内。

3. 手术治疗:采用全麻或连硬外麻醉使腹部肌肉完全松弛。一般沿肿瘤长轴做切口,远离肿瘤 2~3 cm 切开腱膜,肌肉达腹膜;若肿瘤侵犯腹膜则切除部分腹膜。18 例患者肿瘤切除的范围明确在距肿瘤边缘 2 cm 以上。9 例因肿瘤切除后腹部缺损较大而用 Marlex-mesh 行腹壁重建。

4. 放射及内分泌治疗:本组 2 例患者手术后复发而接受放疗,采用直线加速器,总放疗剂量为 5 000~6 000 cGy。其中 1 例多次复发的患者在手术、放疗无效的情况下接受内分泌治疗,口服三苯氧胺 10 mg 每日 3 次

二、结果

本组病例无死亡。所有病例由病理学证实诊断。19 例肿瘤切除后腹壁直接缝合的伤口均 1 期愈合,9 例行 Marlex-mesh 修复腹壁的患者中 1 例出现皮下积液,经适当治疗后痊愈。本组随访 15 例,随访时间为 8 个月至 13 年,平均随访时间 3 年 4 月。随访患者在我院行第一次手术后复发 5 例,其中首诊病例 10 例,复发 2 例,其中,肿瘤长径在 5~10 cm 之间,长径 ≥ 10 cm 各 1 例。5 例复发病例中第 2 次复发 3 例,其中肿瘤长径 ≤ 5 cm、长径 5~10 cm、长径 ≥ 10 cm 者各 1 例。再手术后 1 例复发。在所有复发病例中 1 例第 3 次复发术后辅助放疗,13 年无复发;1 例第 3 次术后辅助放疗 12 个月后又复发,且为多发,再次大范围切除腹壁以及右侧紧贴骨盆壁的肿瘤,部分受侵的髂外静脉和膀胱,术后 11 个月右侧盆壁肿瘤再次复发,后用三苯氧胺治疗 8 个月,CT 证实肿瘤无明显增大。

三、讨论

1. 发病情况:1832 年 Macfarlane 首先报道了 1 例年轻妇女产后不久发现腹壁肌筋膜内肿物即腹壁硬纤维瘤,以后陆续有类似病例报道。国外报道其发病率约为 0.2~0.5/10 万人,占软组织肿瘤的比例不到 3%^[1];约占硬纤维瘤总数的 2/3^[2]。本组 28 例腹壁硬纤维瘤病例约占我院同期收治的软组织肿瘤病例的 1.1% 左右,约占同期硬纤维瘤病例总数的 1/3。

2. 病因:(1)怀孕、腹部手术和腹壁硬纤维瘤的关系:怀孕、腹部手术等致腹壁损伤引起发病已被许多作者所公认。本组 23 例有怀孕史,3 例有腹部手术史,而且此 3 例硬纤维瘤均发生在手术瘢痕区。(2)家族性腺瘤样息肉病(familial adenomatous polyposis, FAP)与腹壁硬纤维瘤的关系:Nichols 早在 1923 年首次报道 FAP 患者易发生硬纤维瘤,有统计结果显示:每年有 2.56/1 000 人的 FAP 患者患有硬纤维瘤,是正常人群的 852 倍;发病部位主要在肠系膜上,也可发生在腹壁,腹壁上的病变可以为单发,也可为多发^[3]。本组有 2 例结肠镜证实有多发性腺瘤样息肉,1 例有 FAP 家族史,另 1 例否认 FAP 家族史但同时伴有会阴部皮脂腺囊肿。鉴于此有人主张 FAP 属高危人群,不应怀孕;或 FAP 患者术后、手术后应给予化疗以预防硬纤维瘤的发生^[4]。(3)性激素与腹壁硬纤维瘤的关系:18~36 岁生育期妇女,绝经后发病者少;不少作者报道巨大腹壁硬纤维瘤可自行消失或在绝经后自然退缩^[2];外源性激素导致了试验动物患纤维瘤^[5];硬纤维瘤的标本中检测到雌激素受体^[1]。本组 28 例中 27 例为女性、生育期妇女。本组病例的这一特点亦支持以上结论,但 3 例患

者术后标本检测的结果并未显示雌激素受体存在。此外,遗传可能与腹壁硬纤维瘤有关,本组 1 例患者的姐姐同样患腹壁硬纤维瘤。还有一些病例病因不清,本组 2 例患者找不到任何诱因,1 例男性患者自幼就发生腹壁硬纤维瘤。

3. 腹壁硬纤维瘤的临床特点:由于腹壁硬纤维瘤不转移,少数硬纤维瘤在外科切除不彻底的情况下可长期存在而不生长,个别巨大腹壁硬纤维瘤不予任何治疗可自然退缩或消失,因此多数作者认为硬纤维瘤是一种良性肿瘤。但是尽管腹壁硬纤维瘤的细胞学特点比较温和,临床上却表现为质硬、边缘不太清楚、有浸润生长的特点。临床中对于已婚、生育期妇女发现腹部质硬、边缘不太清楚的圆形或椭圆形肿块,就应考虑诊断。B 超、CT 可明确肿瘤的部位、大小以及范围,术后病理学检查可鉴别其他软组织肿瘤。此肿瘤虽不转移,但术后局部复发倾向大。Caldwell 报道复发率在 50%~66.8% 之间^[2],而且复发主要在 18~30 岁这一年龄阶段^[4]。本组 28 例中有 5 例是复发后来我院求治的病例,15 例随访患者在我院第一次手术后 5 例复发(5/15),其中 3 例复发 2 次以上。所以认为它是一种类似于低度恶性纤维肉瘤的软组织肿瘤^[4]。肿瘤的复发可能与手术切除范围和肿瘤大小有关。本组患者即有肿瘤愈大愈容易复发的趋势。Plukker 等^[1]也认为:肿瘤大于 10 cm 的病例术后复发率高。

4. 治疗:(1)手术治疗。早在 1899 年 Douffier 就提倡硬纤维瘤要行广泛彻底切除。虽然有作者认为硬纤维瘤是一种良性肿瘤,而且术后复发率高达 50% 以上,因此外科处理是不可取的^[2],然而经过临床实践许多作者已公认:对于首诊的病例应首选广泛彻底切除肿瘤,首次手术切除不彻底与肿瘤复发有直接因果关系^[4,6]。本组首诊的 23 例患者中,随访的 10 例有 2 例复发,这 2 例恰好是在首次手术时切除范围不清楚的患者,而其余 8 例切除范围均距肿瘤边缘在 2 cm 以上。所以我们主张切除范围应距肿瘤边缘至少 2.0 cm,尤其是在肿瘤的纵轴方向上更要保证远离肿瘤 2.0 cm 以上。这一原则对防止腹壁硬纤维瘤术后复发极为重要。对于腹壁肿瘤巨大或多发的病例也应考虑广泛大块切除,如不能做到

这一点,则宁愿放弃手术。因为手术次数越多,复发机会也越大,复发后生长也更快。大块切除后腹壁缺损可用 marlex mesh 重建腹壁,我院曾报道用 Marlex mesh 修复腹壁 16 余例均取得了良好的结果^[7]。(2)放射治疗和内分泌治疗。一些作者认为在外科切除范围不足的情况下术后辅助放疗可以减少复发率^[1,4],放疗的剂量一般为 5 000~6 000 cGy。本组 2 例术后放疗,1 例有效,但病例太少尚难说明问题。内分泌治疗的基础是性激素与腹壁硬纤维瘤生长有关系的观点。Wilcken N 等报道内分泌治疗对单发的肿瘤有效率为 60%。首选药物为三苯氧胺,二线药物是黄体酮激素释放激素(Luteinizing hormone releasing hormone, LHRH)^[8]。二者联合使用有效率达 50%。若能选择切除标本雌激素受体阳性的患者进行内分泌治疗可能会取得更好的结果。本组 1 例多次复发后,其他治疗无效,给予三苯氧胺治疗 8 个月时病情仍基本稳定。

参 考 文 献

- 1 Plukker JT, Oort IV, Vermey A, et al. Aggressive fibromatosis (non-familial desmoid tumour): therapeutic problems and the role of adjuvant radiotherapy. Br J Surg, 1995, 82:510-514.
- 2 Caldwell EH. Desmoid tumor: musculoaponeurotic fibrosis of the abdominal wall. Surgery, 1976, 79:104-106.
- 3 Lynch HT, Fitzgibbons R. Surgery, desmoid tumors, and familial adenomatous polyposis: case report and literature review. Am J Gastroenterol, 1996, 91:2598-2601.
- 4 Posner MC, Shiu MH, Newsome JL, et al. The desmoid tumor - not a benign disease. Arch Surg, 1989, 124:191-196.
- 5 Anthony T, Rodriguez-Bigas M, Weber TK, et al. Desmoid tumors. J Am Coll Surg, 1996, 182:369-377.
- 6 Khorsand J, Karakousis CP. Desmoid tumors and their management. Am J Surg, 1985, 149:215-218.
- 7 朱预,唐伟松,张思源,等.介绍一种腹壁修复材料.中华外科杂志,1988,26:390.
- 8 Wilcken N, Tattersall MHN. Endocrine therapy for desmoid tumors. Cancer, 1991, 68:1384-1388.

(收稿日期:1998-10-29)

(本文编辑:张美娟)

·读者·作者·编者·

关于关键词的标引

本刊增设论著文章的关键词以来,得到广大作者大力支持。但在编辑加工时发现,有些文章所选的关键词不够规范,难以起到标引检索的作用。关键词应是精选的能代表文章主要内容的词,但在发表论文时,为便于读者选读、检索和编制二次文献,需要采用规范化的词,即主题词。按《生物医学期刊投稿的统一要求》,请尽可能根据《医学索引》(Index Medicus)中的医学主题词表(MeSH)中的词条标注。请广大作者协助。

本刊编辑部